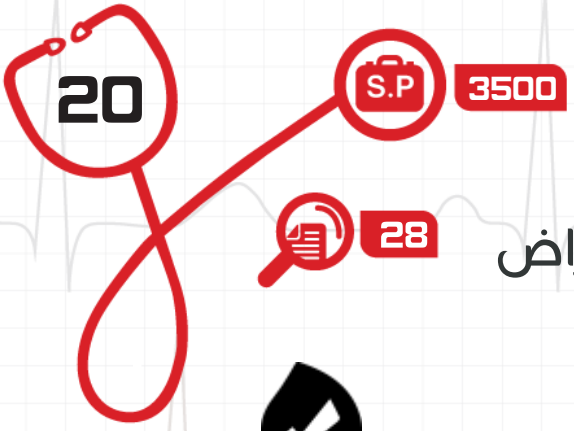




أعراض وعلامات الأمراض الهضمية

3 د. أنس زكية

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

18/11/2024

مدققة

RBC Medicine

المهارات السريرية | Clinical Skills

السلام عليكم

نُتابع معكم أصدقاءنا بالمحاضرة الثالثة في قسم الهضمية وما قبل الأخيرة في هذا القسم والتي سندرس فيها أعراض وعلامات الأمراض الهضمية..

الفهرس

الفقرة	الصفحة
الاضطرابات الهضمية	2
رائحة الفم الكريهة bad breath of mouth	3
العطش وجفاف الفم thirst and mouth dryness	4
جفاف الفم Xerostomia	4
الإلعاب الزائد sialorrhea	4
عسرة البلع Dysphagia	5
الغثيان والإقياء Nausea And Vomiting	9
القلس المعدي المريئي GERD	13
الفواق (الحازوقة) Hiccup	14
التجشؤ Eructation	16
انتفاخ وتطبل البطن Meteorism and Flatulence	16
الإسهال Diarrhea	17
الإمساك Constipation	22
ملخص	26
المصطلحات	28



الاضطرابات الهضمية

↙ سنبدأ بالحديث عن الاضطرابات الهضمية وهي نوعان:

- نقص الشهية (القهم) anorexia
- زيادة الشهية (النهم) polyphagia

أولاً: نقص الشهية (القهم) anorexia

☒ هو نقص أو فقد الشهية للطعام، إما أن يكون كاملاً (يشمل كل الأطعمة) أو انتقائياً (يشمل بعضها) كاللحم غالباً.

☒ عادةً يظهر نقص الشهية كعرض في الأمراض الهضمية والداخلية.

↙ أسباب نقص الشهية:

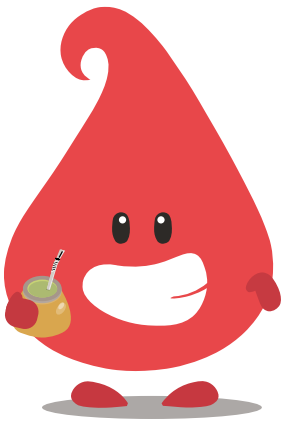
- **أسباب عصبية نفسية**: من أهم المسببات لنقص الشهية، شائع عند الفتيات وخاصة في بداية البلوغ (القهم العصبي)؛ حيث تشعر المريضة بأنها بدينة وتريد إنقاص وزنها فتلجأ للحميات الخاطئة وبعد فترة تعتاد الأمر وتنقص شهيتها، فتخسر المريضة في هذه الحالة على الأقل 25٪ من وزنها الأصلي وتشعر بالبدانة على الرغم من عدم وجوده وتعاني من انقطاع الطمث amenorrhea.
- **أسباب انتانية**: كالأمراض الإنتانية المزمنة مثال: مرض السل أوالحبن أوتشمع الكبد.
- **أسباب هضمية**: كسرطان المعدة الذي يعد من أشيع الأسباب أو القرحة الهضمية (مرضى القرحة الهضمية يصبح لديهم كره للحم).

أي مرض يسبب الاكتئاب قد يؤثر على الهرمونات ويسبب نقص شهية.

ثانياً: زيادة الشهية (النهم) polyphagia

↙ أسباب زيادة الشهية:

- **عصبية نفسية**: وهو السبب الأشيع، مثال: شخص يسارع للأكل كلما تعرض لضغط أو اضطراب نفسي أو شدّة stress.
- **الإصابة بالسكري**: وتترافق مع العطش الشديد.
- **بعض أنواع السمنة العائلية**: عادات عائلية أو أسباب وراثية.
- **فرط نشاط الغدة الدرقية**: نتيجة زيادة الاستقلاب.
- **وجود الديدان بكميات كبيرة**: مثل الدودة الوحيدة أوالدودة الشريطية.



رائحة الفم الكريهة bad breath of mouth

- إنّ 95٪ من حالات رائحة الفم الكريهة تعود إلى تفسخ بقايا الطعام بين الأسنان وتكاثر الجراثيم في اللثة والأسنان مسببة النخور والالتهابات.
- في حال نفي السبب الأول نبحث عن الأسباب الأخرى:

أسباب استقلابية:

- **السبات السكري**: الفم له رائحة الخلّون (الأسيتون).

يلاحظ في حالة السكري المزمن رائحة فم تشبه رائحة البول بسبب ارتفاع نسبة البولة.

- **الانسمام اليوريميائي (القصور الكلوي الحاد)**: تظهر رائحة البول أو السمك.
- **الكحولية**: حيث يتم إطراح الكحول عن طريق النفس أيضاً.
- **التدخين** (أشيع سبب).

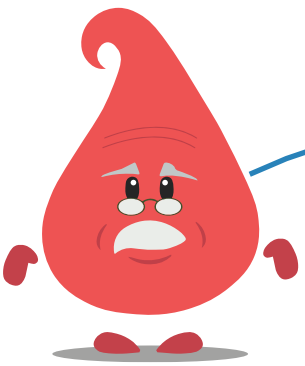
أسباب هضمية:

- **السبات الكبدي (الاعتلال الدماغي الكبدي)**: نتيجة تشمع الكبد في حالة السبات ترتفع مستويات الأمونيا فتصدر رائحة تشبه رائحة التفاح المتعفّن.
- **سرطان المعدة**: حيث إنّ ركودة الطعام في المعدة لساعات طويلة بسبب انسداد مخرجها يؤدي إلى تخمرالأطعمة وظهور رائحة فم كريهة.
- **انسداد الأمعاء**: بسبب ركودة الطعام سواءً كان في المعدة أو في القولون؛ حيث تتراكم الفضلات لمدة تتجاوز ال 10 أيام، وقد يتحول لون البراز في هذه الحالة إلى رصاصي ذو رائحة شديدة.

أسباب رئوية:

- **الخراجات والإنتانات التنفسية وتوسع القصبات**.

أحياناً قد لا تكون أي من الأسباب السابقة هي السبب في ذلك فنلجأ إلى إعطاء المريض العلكة أو أي شيء يزيل هذه الرائحة.



Life makes us appreciate the beautiful moments and the people who love us

العطش وجفاف الفم thirst and mouth dryness

العطش أحد وسائل الدفاع في الجسم، يعتبر مشعر لنقص السوائل في الجسم حيث يعكس درجة التجفاف الخلوي (نقص التميه)، وينجم إما عن نقص الوارد المائي، زيادة طرح الماء، زيادة استهلاك الملح أو إعطاء سيرومات ملحية بشكل كبير.

أهم أسبابه:

- **الإسهال**: حيث يأتي في المرتبة الأولى وخاصة الإسهالات الحادة.
- **السكري**: حيث يسبب البوال السكري.
- **القصور الكلوي**: وخاصة القصور الكلوي **الحاد** حيث يحدث اضطراب في طرح الشوارد (احتباس شوارد الصوديوم) وبالتالي اضطراب في طرح الماء كما تتفعل جملة الرينين أنجيوتنسين التي تحبس السوائل.
- **التعرق الشديد**.

جفاف الفم Xerostomia

يدل على نقص السوائل الخلوية.



أسبابه:

- **أمراض الغدد اللعابية** التي تؤدي إلى اضطراب مفرزات هذه الغدد.
- **التجفاف** نتيجة إسهال شديد (ضياع السوائل) أو نقص الوارد المائي.
- **التنفس من الفم**: في حالة فتح الفم أثناء النوم.
- **الأدوية**: تعد من أهم أسباب جفاف الفم، يظهر كتأثير جانبي للعديد من الأدوية، **مثال**: الأدوية المضادة للتشنج والأدوية المضادة للكولين.

الإلعاب الزائد sialorrhea

زيادة إفراز اللعاب عن المستوى الطبيعي حيث تبلغ كمية اللعاب **1 لتر** يومياً في الحالة الطبيعية.

أسبابه:

- **القلق**: من أهم الأسباب على الاطلاق، فأي إلعاب زائد غير مترافق بأعراض أخرى يعود إلى القلق.
- **انسدادات المريء**: حيث لا يتم ابتلاع اللعاب.

- **التهابات الفم**: يزداد اللعاب نتيجة المفرزات الالتهابية ويلاحظ احمرار وتورم حول الشفتين.

الحروق تسبب زيادة إلعاب نتيجة شرب مادة كاوية إضافة للجلطات الدماغية أوعسرة بلع.

عسرة البلع Dysphagia

✪ انزعاج بعملية البلع، ويجب أن تستقصى دوماً.

يمكن التمييز بين نوعين من عسرة البلع:

- **عسرة بلع فموية:** الشعور بصعوبة إفراغ الفم من الطعام بعد مضغه، قد تكون ذات آلية مركزية كمشكلة دماغية أو قد تنتج عن أورام في الفم والبلعوم أو التهاب البلعوم والتهاب اللوزات وفي قرحات الفم المؤلمة.
- **عسرة بلع مريئية:** صعوبة إمرار اللقمة عبر المري وشعور بغصة خلف القص وكأن الطعام يستقر في هذا المكان.

أسباب عسرة البلع

أسباب ميكانيكية (سبب يعيق البلع):

❄ **داخل المريء**: يشعر المريض بتوقف اللقمة ويحتاج لشرب ماء لعبورها.

نراها في: حالات سرطان المريء، التهاب المريء القرحي، فتق مريئي، أورام سليمة، انسداد بأجسام أجنبية، حلقة شاتسكي[1]، حدوث التهاب نتيجةً للإنتان أو للعديد من المواد المخرشة.

❄ **خارج المريء**: حالات أورام الرئة والقصبات، أورام والتهابات المنصف وأعلى البطن، أورام الدرق، الانضغاط الخارجي من أي جسم أجنبي أو غشاء أو التهاب يضغط على المريء **مثال:** سرطان الرئة.

أسباب وظيفية حركية (خلل في حركية المريء):

❄ قد تكون بسبب تضيق أسفل المري وزيادة ضغط المعصرة المريئية السفلية.

↙ أشهر الاضطرابات الحركية:

☒ المريء العرطل الولادي: "الأكاليزيا" achalasia[2].

☒ تشنج المري المعمم.

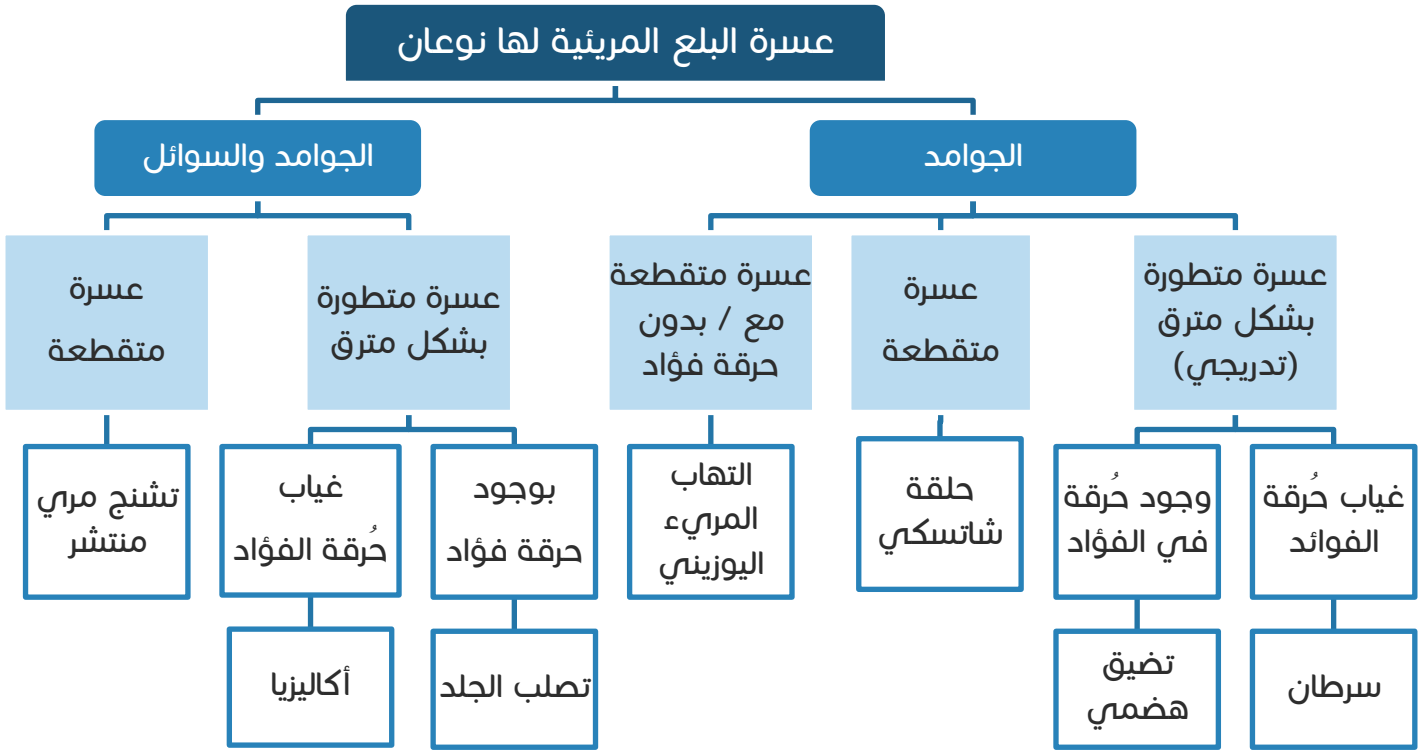
☒ أمراض عامة تصيب تعصيب المريء أو عضلاته على أي مستوى من المستويات (رقبي-صدري-شرسوفي).

[1] رابط شرح عن حلقة شاتسكي: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8902418.

[2] للمزيد حول المرض: https://www.healthline.com/health/achalasia#treatments6.

مثل: السكري أو نزع الميالين من الأعصاب.

☒ تصلب الجلد والوهن العضلي الوخيم اللذان يؤثران على عضلية المريء.



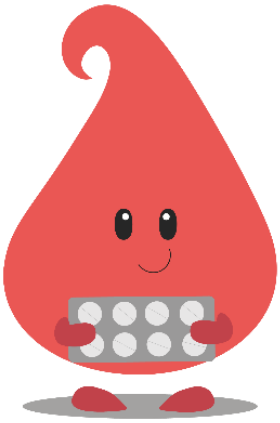
استجواب مريض عسرة البلع

▣ إن الفحص السريري في عسرة البلع فقير جداً (لا يعطي معلومات كافية) لذا لابد من القيام باستجواب صحيح لأن الاستجواب يعتبر الأساس في تشخيص أسباب عسرة البلع.

▣ مفتاح علاج عسرة البلع هو في تحديد نوعها: ميكانيكية أو حركية.

↙ نسأل في الاستجواب عن السوابق التالية:

1. التدخين والكحول: لأن نسبة حدوث سرطان المريء تزداد بالتدخين والكحول نتيجة تخريش المريء.
2. أعراض التهاب مريء سابقة: لأنها تؤدي إلى تضيق المري في وقت لاحق من الإصابة بالالتهاب.
3. لذع (حرقة): قلس معدي مريئي.
4. تناول مواد كاوية سابقاً رغبةً بالانتحار أو عن طريق الخطأ.
5. تعرض المريض لعلاج شعاعي.
6. تناول بعض الأدوية: كالأدوية التي تعالج حب الشباب أو المالطية.
7. إصابة المريض بالسل.
8. هل يعاني المريض من داء السكري؟
9. صفات عسرة البلع: مؤلمة أم غير مؤلمة؟ متقطعة أم مترقية؟



غالبا مكان عسرة البلع يدل على مكان الإصابة.

يكون تمييز عسرة البلع الحركية عن عسرة البلع الميكانيكية من خلال

1. **زمن بدء عسرة البلع:**
   - عسرة بلع **حديثة** ← غالباً **العسرة ميكانيكية** (سرطان لا يتجاوز الشهر).
   - عسرة بلع **قديمة** تحدث بشكل متردد ← غالباً **العسرة حركية**.
2. **شكل البدء ونمط الأطعمة:**
   - إذا كان البدء **تدريجي** كالأورام ← عسرة بلع للأطعمة الصلبة ثم نصف السائلة ثم السائلة فغالباً **الآفة ميكانيكية**.
   - إذا كان البدء **مفاجئاً** ← عسرة البلع تشمل فور بدايتها الأطعمة الصلبة والسائلة فغالباً **الآفة حركية**.
3. **منطقة عسرة البلع:** رقبية، صدرية أو شرسوفية.
4. **درجة عسرة البلع:** بسيطة، شديدة أو نهائية.
5. **الاستجابة لمحاولات البلع المتكررة والاستعانة بالسوائل:** تكون الاستجابة **فاشلة** في الآفات **الميكانيكية**، أي تعود الأطعمة لتخرج عبر الفم، بينما تكون **فعالة** في الآفات **الحركية**.
6. **العلاقة مع حرارة الأطعمة:** **عديمة الأهمية** في الآفات **الميكانيكية** فلا تتأثر بحرارة الطعام، أما إذا كانت الحالة **تسوء في حالة الطعام البارد** فالعسرة غالباً **حركية** مثال: عند شرب الماء البارد بسرعة وبشكل مفاجئ نشعر بعسرة بلع (تقلص عضلية المري).
7. **الأعراض المرافقة:**
   - نقص الوزن نتيجة عدم تناول الطعام بسبب ألم المري أثناء البلع كما في تشنج المريء المعمم (آفة حركية).
   - سوابق قلس معدي مريئي: فغالباً سبب عسرة البلع التهاب المريء الهضمي (آفة ميكانيكية).
   - فرط اللعاب: لعدم القدرة على بلع اللعاب (آفة ميكانيكية).
   - تجشؤ مؤلم.
8. **الإجراء اللازم:** نطلب من المريض في حال وجود عسرة بلع تنظيراً للمري ونكون أمام حالتين:
   - المري سليم من الناحية التشريحية ← عسرة البلع حركية.

   وفي هذه الحالة (أي في حالة عسرة البلع الحركية) نجري قياس ضغوط للمريء لتأكيد التشخيص.
   - كتلة سادة للمري ← عسرة البلع ميكانيكية.

في هذه الحالة نأخذ خزعة للتأكد من طبيعتها وفي حال كان هناك ضغط خارجي على المريء نشك بأورام في الصدر فنطلب صورة شعاعية للصدر بالأشعة السينية أو بالتصوير الطبقي المحوري.

	ميكانيكي	حركي
منطقة عسرة البلع	رقبية - صدرية - بطنية	
درجة عسرة البلع	بسيطة - شديدة - نهائية	
زمن البدء	حديث	قديم
شكل البدء ونمط الأطعمة	تدريجي: صلبة ثم نصف سائلة ثم سائلة	مفاجئ: صلبة وسائلة
محاولات البلع	-	+
حرارة الطعام	-	+
تطور الحالة	مستمرة للأسوء	متقطعة - ثابتة
أعراض مرافقة	نقص الوزن - ألم مريء - قلس - تجشؤ - فرط إلعاب	

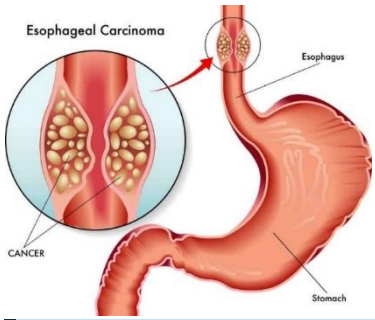
الفحص السريري

- قليل الأهمية لكنه يفيد أحيانا في تشخيص بعض الحالات مثل:
  - في سرطانات المريء نلاحظ ضخامة عقد لمفاوية.
  - فحص البلعوم والغدة الدرقية يمكن أن يوجهنا إلى تشخيص معين.

التشخيص

هناك أربع أمراض رئيسية مسببة لعسرة البلع:

1. سرطان المريء:

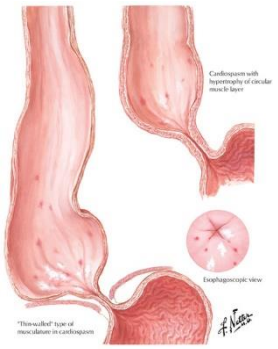


- غالباً يكون المريض ذكر مدخن أو كحولي.
- مع عسرة بلع ميكانيكية حديثة تتطور إلى الأسوء.
- وهنا نقوم بتنظير هضمي علوي مع أخذ خزعات لإثبات التشخيص.

2. التهاب المريء الهضمي:

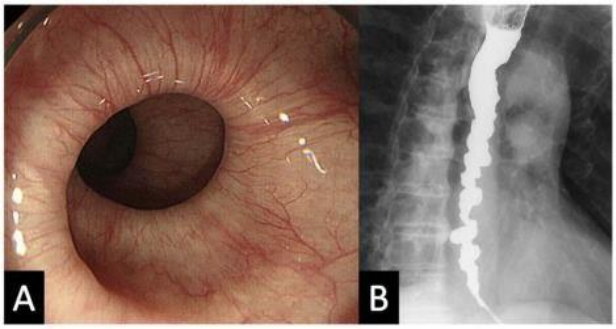
- شعور بحرقة وحموضة مزمنة مع قلس معدي مريئي شديد.
- بحالة التهاب المري الهضمي بدرجاته المختلفة يترافق بانكماش وتضيق مريئي وعسرة بلع تدريجية.

3. المريء العرطلي الولادي (أكاليزيا Achalasia):



- حيث تفشل **المعصرة المريئية السفلية بالارتخاء** بشكل طبيعي فتؤدي إلى توسع المري بشكل مترقي فوق المعصرة.
- لا يوجد ألم عادةً ويتميز **بقلس غير حامضي**.
- يتم التشخيص بالتنظير وإجراء صورة ظليلة وقياس ضغوط المري.
- العلاج: إما دوائي أو توسيع بالبالون أو جراحي.

4. تشنج المريء المنتشر:



- عسرة بلع حركية.
- يترافق بألم شديد خلف القص.
- يدخل بالتشخيص التفريقي الألم القلبي ويجب نفي الألم القلبي أولاً.
- التشخيص: إجراء تنظير لنفي الآفة الميكانيكية وإجراء صورة ظليلة وقياس ضغوط المريء.

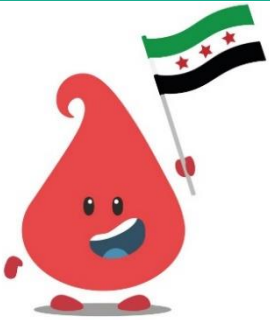


هل تعلم أنه يوجد إجراء تشخيصي لفحص المريء يسمى بلعة الباريوم

الغثيان والإقياء Nausea And Vomiting

- **الغثيان**: الشعور بالرغبة في الإقياء يسبق أو يرافق أو ينتهي بدون إقياء ويشعر به في الحلق أو الشرسوف.
- **الإقياء**: إخراج مفاجئ وقسري لجزء أو لكامل محتوى المعدة عن طريق الفم.
- يجب تفريق الإقياء عن القلس Regurgitation والاجترار Rumination.

- **الاجترار:** هو قلس محتويات المعدة اللا إرادي بشكل متكرر ودون وعي ثم مضغها وبلعها من جديد، وهو غير شائع.



الفيزيولوجيا المرضية

- الإقياء فعل انعكاسي يتحرض بمستقبلات حسية منتشرة في كامل الانبوب الهضمي، البريتوان، دهليز الاذن والدماغ[3] ويقع مركز الإقياء في البصلة السيسائية.

أسباب الإقياء

أسباب هضمية:

- **إصابات المعدة:** (اشيع سبب هضمي) **مثل:** التهاب معدة كحالات التسمم غذائي، قرحة معدية أو عفجية، تضيق بواب المعدة.
- **إصابات الأمعاء والقولون:** التهاب أمعاء أو انسدادها.
- **إصابات الطرق الصفراوية:** التهابات أو انسداد الطرق الصفراوية بالحصيات.
- **التهابات البنكرياس.**
- **التهاب وتخريش البريتوان:** كالمرارة أو الزائدة الدودية.



أسباب غير هضمية:

- **عصبية (أهم الأسباب غير الهضمية):** كالشقيقة وأورام الدماغ، كما أن زيادة التوتر داخل القحف يحرّض مركز الإقياء في البطين الرابع أو قد يحدث الإقياء في حالات التهاب السحايا.
- **نسائية:** كما في الحمل (أنثى في سن النشاط التناسلي مع انقطاع الدورة الطمثية لمدة شهر أو أكثر، أول تشخيص تفريقي لحالتها هو الحمل)، التهابات تناسلية.
- **دوائية:** يظهر الإقياء كأحد الآثار الجانبية لمعظم الأدوية بما فيها مقويات العضلة القلبية مثال: الديجيتال والديجوكسين.
- **أمراض استقلابية وغدية:** فرط التميه (كما في حالة إعطاء الكثير من السيرومات)، أو فرط **كالسيوم** الدم والقصور الكبدي.
- **كلوية:** مثل القصور الكلوي الحاد، قولنج كلوي.
- **إصابات الدهليز في الأذن الداخلية:** (أشيع سبب غير هضمي) وهنا يترافق الإقياء مع طنين ودوار.
- **الاضطرابات النفسية:** وعلى رأسها القهم (فقدان الشهية) حيث يمكن أن يشكو المريض من الإقياء نتيجة شم رائحة الطعام كما يمكن أن يوجد لدى بعض الأشخاص حساسية نفسية عند رؤية مشهد ما.

IMP

[3] لذلك أي تخريش للبريتوان أو التهاب لأنبوب الهضم أو الإصابات الأذنية للدهليز ستسبب الإقياء.

ملاحظات هامة:

- الإقياء المتكرر للمريض يمكن أن يسبب اضطراب شاردي وقلاء استقلابي بسبب نقص البوتاسيوم والتجفاف كما أن الحالات الشديدة من الإقياء تسبب انثقاب المري (تناذر بورهاف) Boerhaave's Syndrome.
- قد يؤدي تناول الأسبرين أو شرب كميات كبيرة من الكحول إلى الإقياء الدموي بسبب تمزق مخاطية القسم السفلي من المريء والذي يعرف بمتلازمة مالوري وايس mallory weiss syndrome.
- القولنج الكلوي ألم في منطقة الكلية أو الحالب نتيجة حصى أو رمل يسبب ألم بطني مترافق مع إقياء.

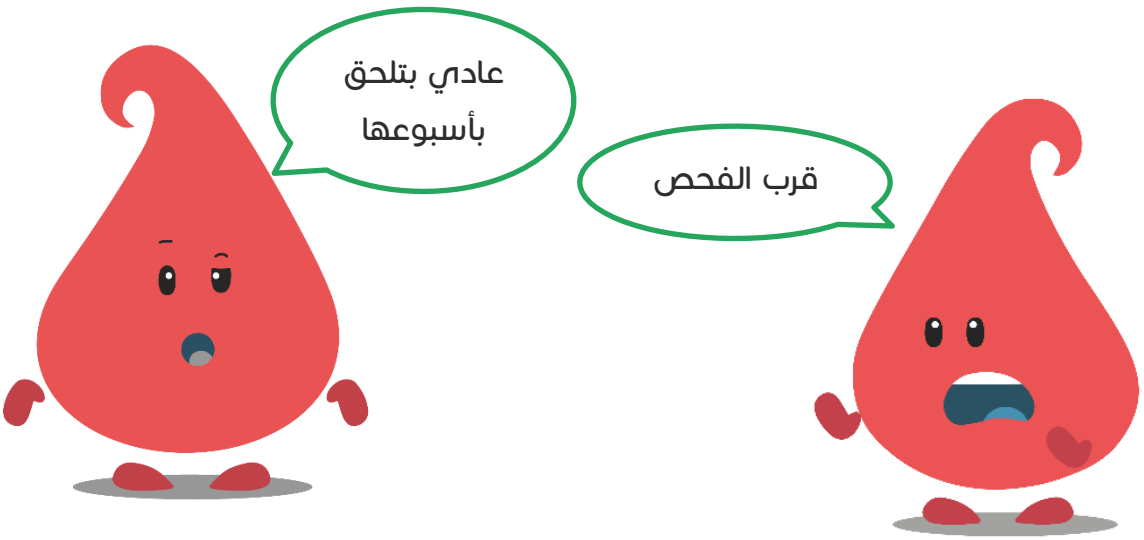
يوجد نوعين للإقياء هما:

1. **إقياء بدون ألم:** تسممات – التهابات جرثومية – شدة داخلية.
2. **إقياء ناتج عن الألم:** كما في حالات التهاب الزائدة الدودية، التهاب البنكرياس وأي شيء يقوم بتخريش البريتوان.

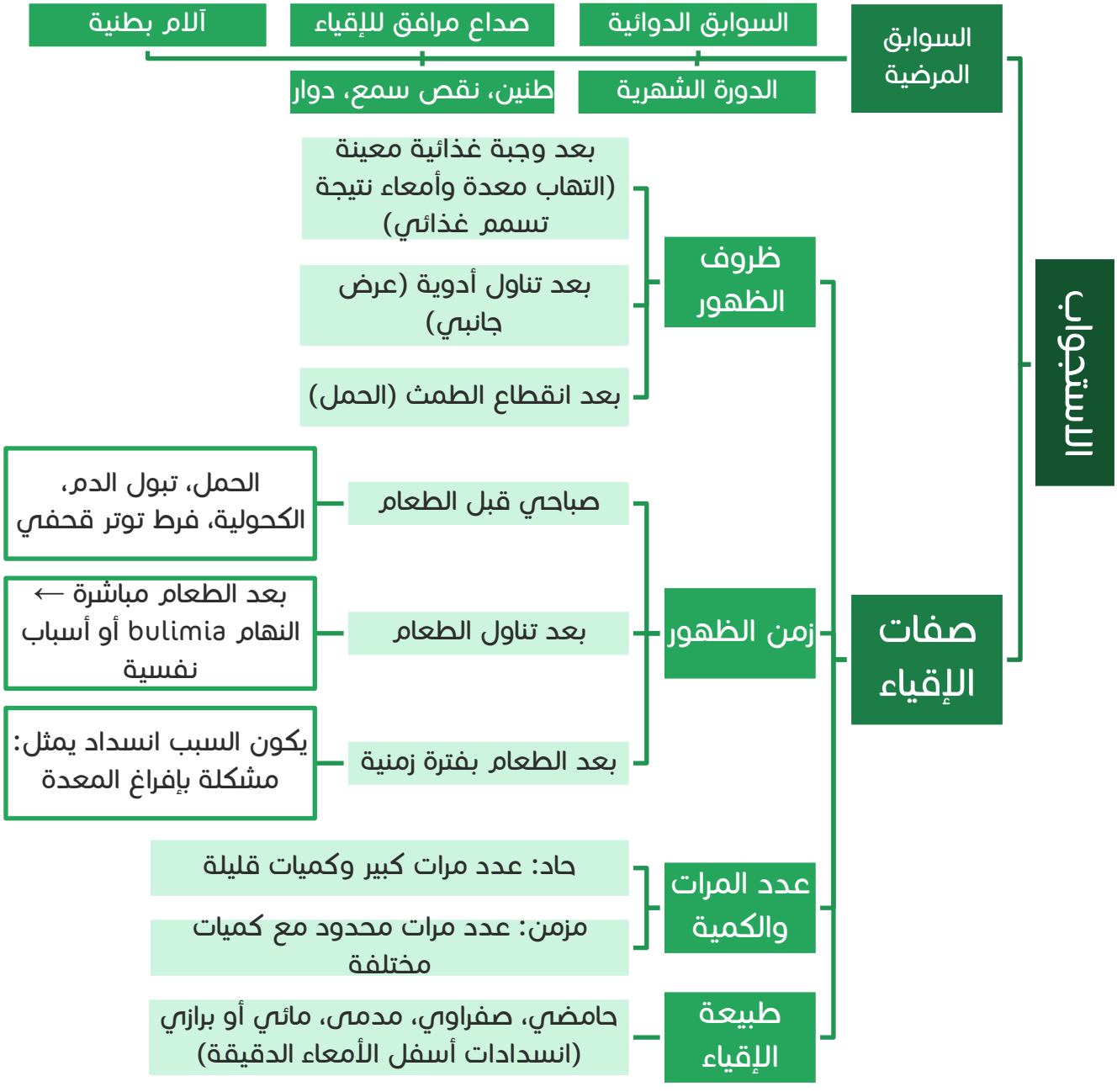
المريض في هذه الحالة يعالج الآفة ← يزول الألم ويتوقف عن الإقياء.

مراجعة سريعة:

- تناذر بورهاف: انثقاب في كامل طبقات المري نتيجة للحالات الشديدة من الإقياء.
- متلازمة مالوري وايس: إقياء دموي نتيجة تمزق في مخاطية القسم السفلي من المري نتيجة لتناول الأسبرين أو كميات كبيرة من الكحول ويكون شائع عند الحوامل.



الاستجواب



الفحص السريري

✓ في الفحص السريري نبحث عن انعكاس الإقياء على الحالة العامة (نقص وزن، نقص تميه)، فنستقصي الأمور الأربعة التالية:

- هل يبدو على المريض التجفاف؟
- هل يوجد هبوط في العيون؟
- جفاف في الفم؟
- هل الجلد مهلهل؟

✓ ونبدأ البحث عن السبب مثال: صلابة النقرة ← التهاب سحايا.

الفحوص المتممة

- إقياء مع صداع ← دائماً وأبداً نبحث عن التهاب السحايا ونطلب CT SCAN للرأس.
- نفحص قعر العين ووذمة حليمة العصب البصري للبحث عن فرط التوتر القحفي.
- عند الشك بآفة معدية أو كولونية نطلب تنظير هضمي علوي وسفلي.
- عند الشك بقولنج مراري نطلب إيكو بطن.

القلس المعدي المريئي GERD[4]



- **اللذع (حرقة الفؤاد) heartburn:** هو شعور لاذع خلف القص (حرقة أو حموضة) يحدث بعد فترة وجيزة من تناول الطعام، يزداد بالانحناء للأمام، ينتج عن قلس المعدة الحامضة (وأحياناً الصفراوية) إلى المريء.

الفيزيولوجيا المرضية

- في الحالات الطبيعية ينتهي المريء الصدري بعبوره الفتحة المريئية في الحجاب الحاجز ثم يدخل إلى المعدة، فتساهم الفتحة المريئية بالإضافة لعوامل أخرى في منع ارتداد الطعام إلى المري.

أسباب القلس المعدي المريئي

1. اضطرابات الوصل المريئي المعدي (الفؤاد):

- ✓ في الحالة الطبيعية ينغلق الفؤاد بعد مرور الطعام بوساطة مصرته أما في الحالة المرضية يضطرب عمل هذه المصرة فيحدث القلس المعدي المريئي.

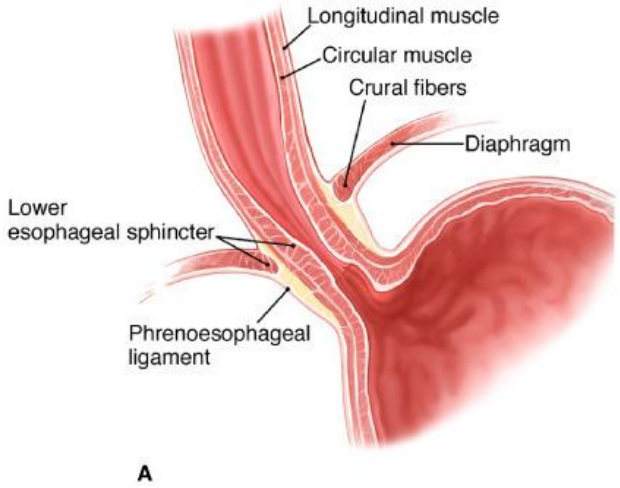
2. اضطرابات في حركية المري والمعدة:

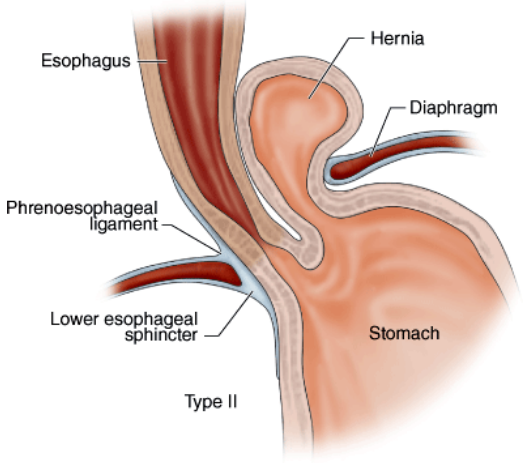
- ✓ عندما ننفي وجود مشكلة تشريحية في المري أو البنى المجاورة، وتظهر النتائج على أنها طبيعية عند إجراء التنظير، نتجه للتفكير بالاضطرابات الحركية. فكما نعلم أن الحركات الحوية الطبيعية للمعدة تبدأ من جهة المري وتتجه نحو الأمعاء الدقيقة، لكن في بعض الحالات المرضية تكون هذه الحركة معكوسة أي تحدث التقلصات الحوية باتجاه المري.

3. فتق معدي حجابي انزلاقي:

- ✓ خروج جزء من المعدة (الوصل المعدي المريئي Gastroesophageal junction) من تجويف البطن وتوضعه في تجويف الصدر وينجم عن زيادة الضغط في تجويف البطن في حالات السمنة، الحمل، الإمساك، السعال المزمن.

[4] Gastroesophageal reflux disease، إكسترا حسب ماكلاود: اختصار القلس المعدي المريئي GORD GASTRO-Oesophageal reflux disease).





الاستجواب

1. نسأل المريض متى بدأ الشعور بالحرقة؟ منذ فترة طويلة أم قصيرة.
2. نسأل المريض عن الأعراض المرافقة مثال: يترافق الفتق المعدي الحجابي مع التجشؤ.
3. نستفسر عن ترافقه مع عسرة بلع؟ إذا وجدت فغالباً نحن أمام حالة التهاب مري.
4. نسأل عن وجود تناذر قرحي.

التشخيص

1) **تنظير هضمي علوي UGIE**[5]: للبحث عن توسعات الفؤاد أو الفتق المعدي الحجابي الانزلاقي أو اضطرابات حركية.

في الحالة الطبيعية يظهر طول المريء من المعصرة العلوية إلى الوصل المعدي المريئي 25سم، ومن القوس السنية إلى الوصل 40 سم، ونرى عند إجراء التنظير الهضمي العلوي العنق الحجابي ثم الوصل المريئي المعدي.

2) **قياس حموضة أسفل المري PH monitoring**: وذلك خلال 24 ساعة لمعرفة درجة القلس علماً أنه في الحالة الطبيعية يوجد قلس معدي مريئي ولكن بكميات قليلة جداً.

الفواق (الحازوقة) Hiccup

☒ عبارة عن **تشنجات في عضلة الحجاب الحاجز** تحدث بسبب تخريش موضعي للحجاب الحاجز أو بتخريش الأعصاب المعصّبة له.

☒ ممكن أن تكون سليمة تحدث عند التعرض للجو البارد – شرب المشروبات الغازية – تناول المواد الباردة.

☒ تعالج بطلب فعل شيء غير مألوف **مثل:** (تناول سكر، شرب ماء بارد، رعب المريض).

[5] Upper gastrointestinal endoscopy.

أسباب الحازوقة

1. تخريش عصب الحجاب الحاجز:

- تمدد المعدة بفقاعة هوائية (أهم سبب على الإطلاق يشكل 95٪ من حالات تخريش العصب الحجابي) وسبب هذه الفقاعة الهوائية **هو تناول المشروبات الغازية**، **مضغ العلكة** (فمع المضغ المستمر يقوم الشخص ببلع الهواء) **ودخول كمية من الهواء أثناء بلع الطعام**.
- التبريد المفاجئ للمعدة مثال: شخص خرج من الحمام في جو بارد.
- أورام المعدة والرقبة والمنصف.

2. تخريش الحجاب الحاجز بشكل مباشر:

- خراجات تحت الحجاب.
- التهاب البريتوان (بسبب انصباب حشا أجوف أو التهاب زائدة أو التهاب بنكرياس أو التهاب سائل حبن عفوي).
- انتقالات ورمية إلى البريتوان كما في سرطان المعدة والقولون.

3. إصابات عصبية مركزية:

- كل ما يحرض المنطقة المركزية المعصّبة للحجاب الحاجز في قاع البطين الرابع في الدماغ.
- التهابات.
- أورام: يترافق عندها الفواق مع صداع شديد وإقياء.
- الانسمامات العامة:

مثل: الانسمام اليوريميائي، السبات الكبدي والاعتلال الدماغي الكبدي في قصور الكبد.

- المعالجة العرضية: تخريش البلعوم بهدف تخريش العصب الراجع – نسحب اللسان -التنفس ضمن كيس نايلون مما يؤدي لنقص الأكسجة وبالتالي إيقاف تنبيه العصب الراجع – مناورة فالسافا – نعطي المريض بعض السكريات.

Extra

مناورة فالسافا: هي عملية تشتمل محاولة الزفير عند إغلاق المجرى التنفسي عن طريق إغلاق الفم والضغط على الأنف لإغلاقه ومحاولة إخراج الهواء كما في حالة نفخ البالون.



التجشؤ Eructation

- هو عبارة إخراج هواء بشكل إرادي أو لا إرادي من المعدة أو المري.
- في 90٪ من حالات التجشؤ تحدث بسبب اضطرابات حركية المعدة (اضطرابات وظيفية).
- يحدث غالباً وبشكل متكرر بعد الوجبات حيث تتمدد المعدة مما يؤدي لارتخاء عابر في معصرة المري السفلية.
- حيث تتمدد المعدة بالهواء ففي كل عملية بلع يتم بلع 2-3 مل من الهواء.

ملاحظات:

- كل الهواء في المعدة مصدره الهواء المبتلع.
- إذا كانت الحالة مترافقة مع أعراض أخرى مثل: عسرة البلع، الشبع المبكر أو إقياء نجري تقييم للمريض (تنظير معدة).

انتفاخ وتطبل البطن Meteorism and Flatulence

- هو تمدد المعدة والأمعاء بوجود الغاز وهو أشيع الأعراض الهضمية على الإطلاق [6] 60٪ تقريباً.

الأسباب

1. تمدد المعدة بالغازات (نفخة شرسوفية):

- نتيجة اضطراب وظيفة المعدة.
- بقية الأسباب تكون عضوية كالالتهابات والقرحات والسرطانات.
- هذه النفخة تتحسن بالتجشؤ.

2. تمدد القولون بالغازات (نفخة معممة):

- نتيجة اضطرابات حركية (اضطراب وظيفة القولون)، كما في **تهيج القولون IBS**[7] **أشيع سبب لنفخة البطن**.
- بقية الأسباب عضوية كالأورام، التهابات القولون المزمنة والتقرحات.
- هذه النفخة تتحسن بإخراج الغازات الشرجية.



[6] يُعتبر رقم كبير جداً.

[7] أي القولون العصبي الناجم عن تقلص غير متجانس للقولون وتشكل جيوب هوائية تعطي الشعور بالنفخة.

ملاحظات:

- الفرق بينهما: إن النفخة التي تتحسن بإفراغ الغازات عن طريق الشرج ناتجة عن تشنج كولون، والنفخة التي تتحسن بالتجشؤ ناتجة عن عسرة هضم علوية (سبب معدي).
- أغلب النفخات التي تحصل بعد الأكل هي كولونية وليست معدية.

الإسهال Diarrhea

- هو زيادة عدد مرات التغوط لأكثر من ثلاث مرات في اليوم، ويلاحظ فقدان البراز قوامه الطبيعي وزيادة السوائل فيه حيث يزداد وزن البراز لأكثر من 200غ في اليوم.

أنواع الإسهال[8]

الإسهال الحاد Acute diarrhea	الإسهال المزمن Chronic diarrhea

الإسهال الحاد

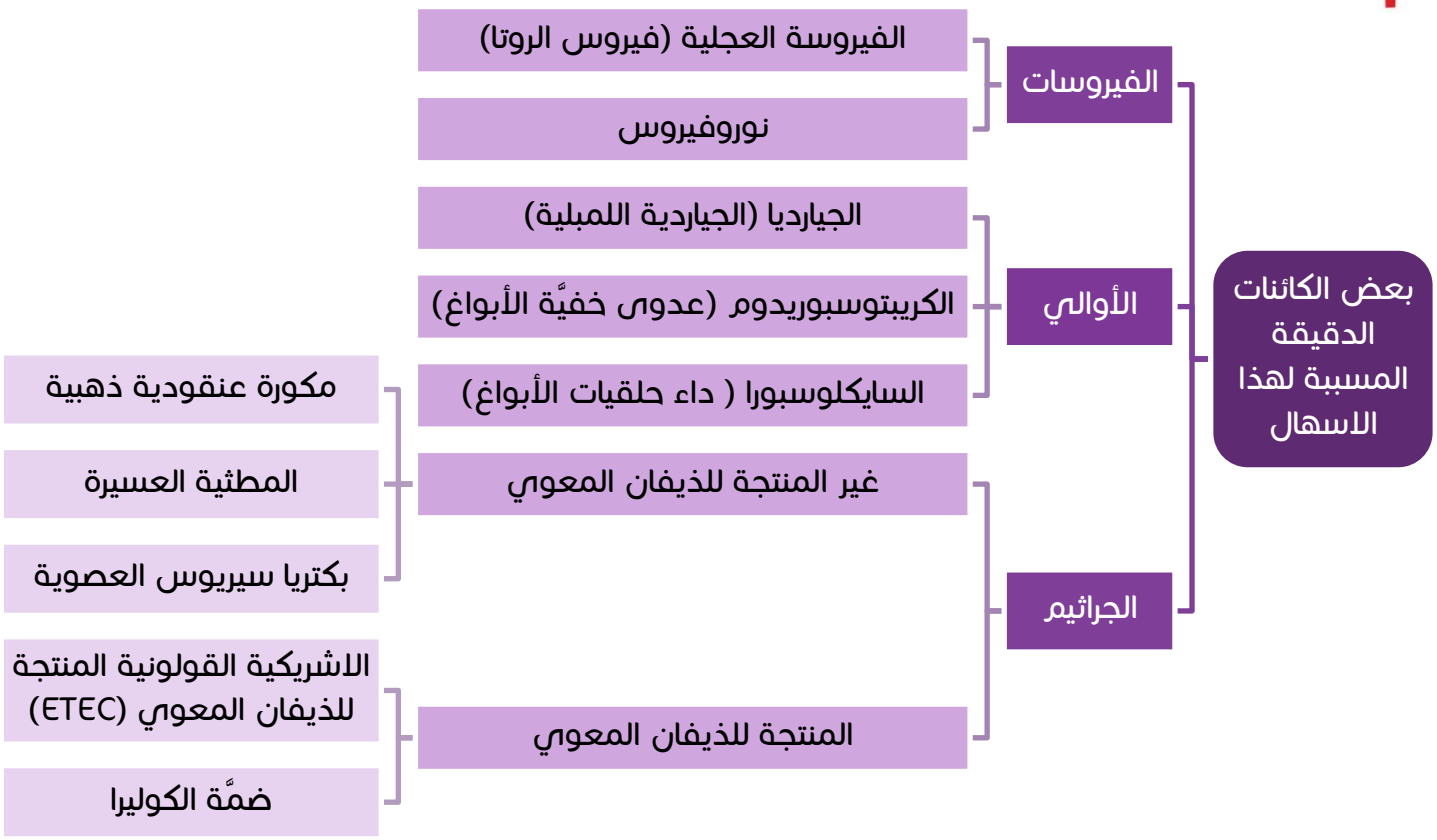
- يستمر عادةً أقل من أسبوعين وينجم عن عوامل ممرضة غازية أو غير غازية للمخاطية مع سمومها المعوية.
- **ويقسم إلى:**

إسهال حاد لا التهابي non inflammatory diarrhea:

- الإسهال مائي بدون دم أو مخاط أو قيح ويكون خفيف عادةً ومحدد لنفسه.
- تسببه الفيروسات أو الأوالي كالجيارديا لامبليا Giardia lamblia أو الجراثيم غير الغازية.
- لا حاجة للاستقصاءات التشخيصية إلا في الحالات الشديدة والمستمرة أكثر من أسبوع.

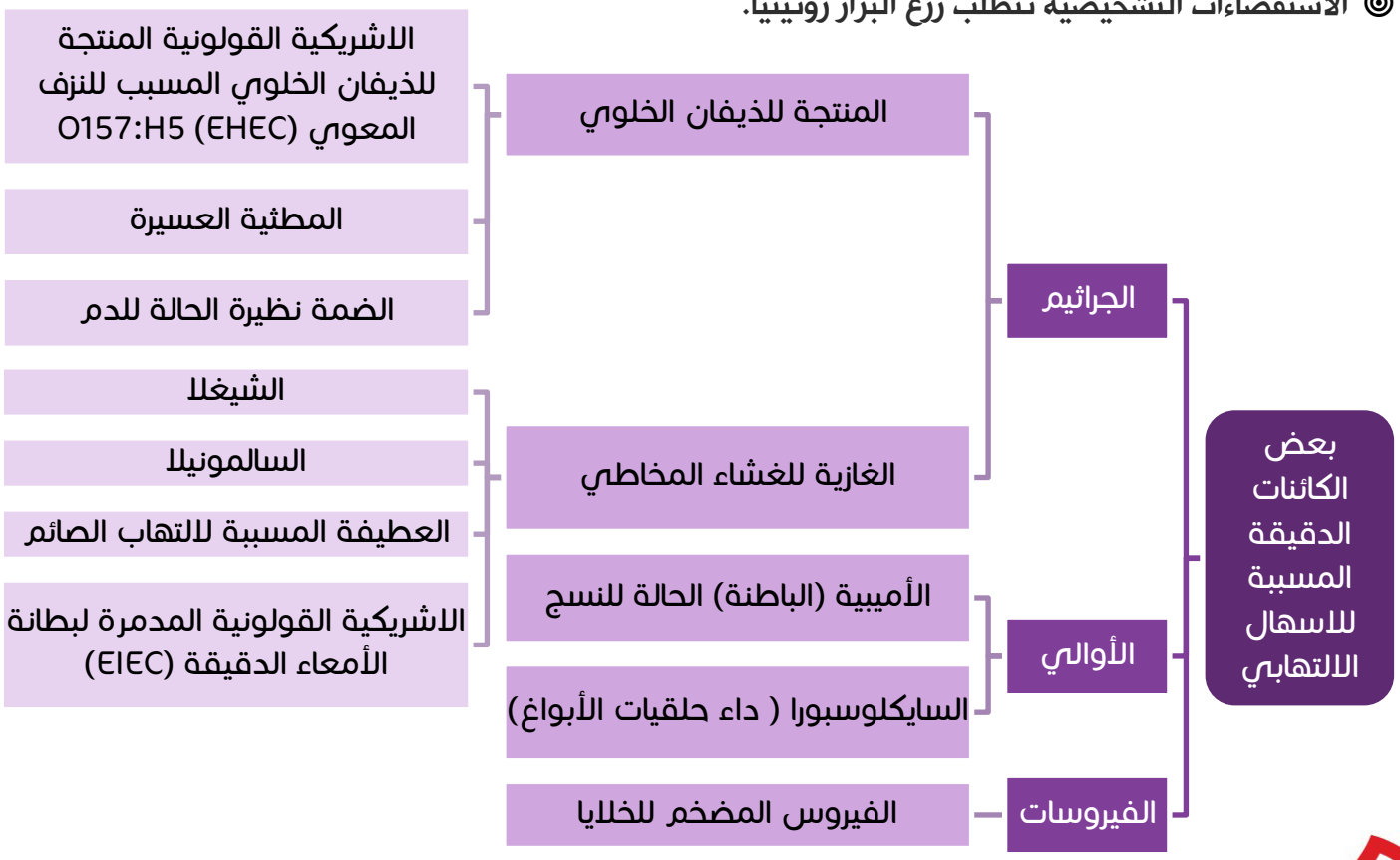


[8] هذه الفقرة تحوي بعض المعلومات الواردة باللغة الإنكليزية في سلايدات الدكتور وقمنا بترجمتهم بناءً على طلبه لكن فيما بعد قال أنّها للإيضاح، فالأفضل دراسة المعلومات المبنية على الأرشيف في هذه الفقرة وقراءة المعلومات الإيضاحية تحسباً لاي سؤال قد يرد منهم.



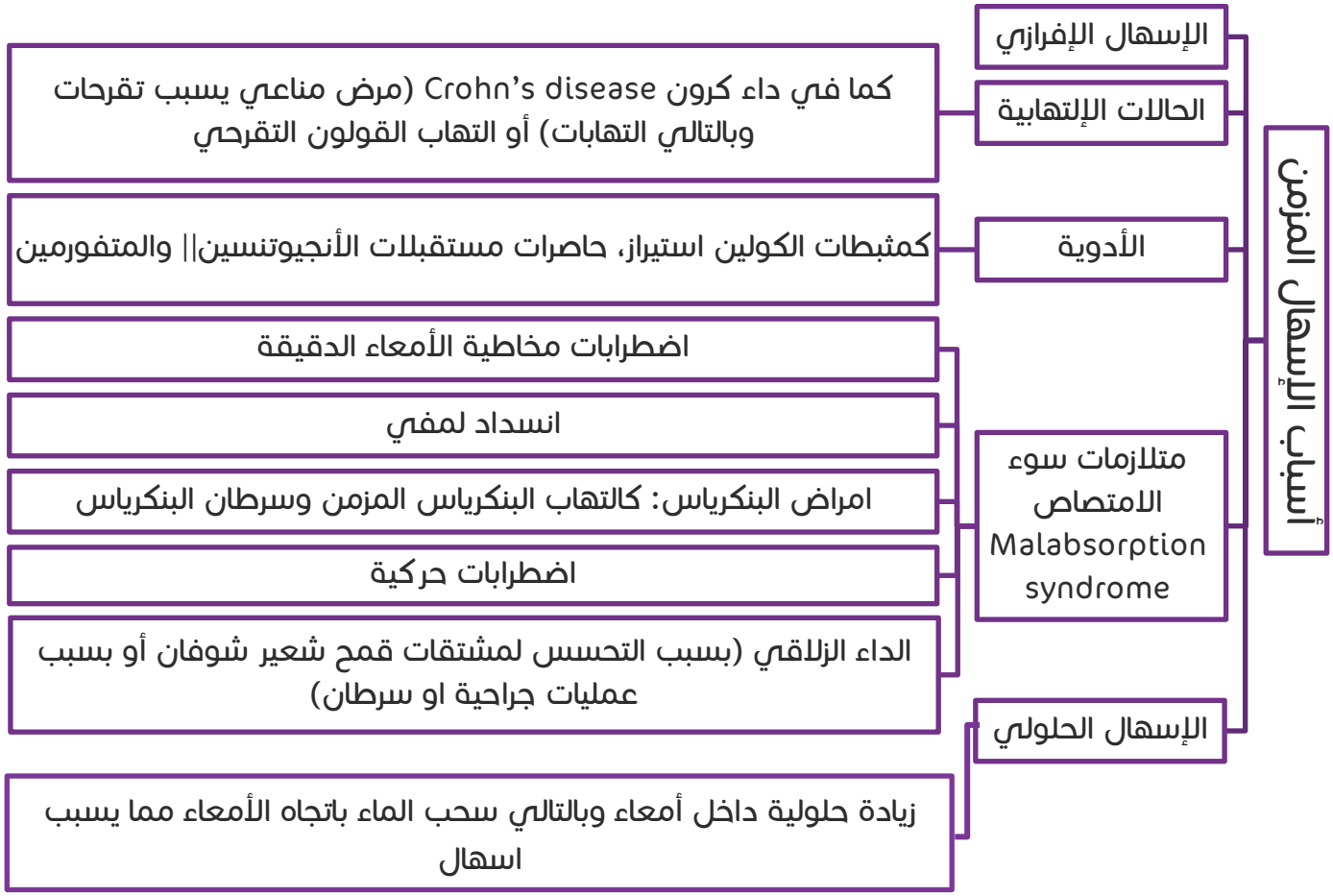
الإسهال الحاد التهابي inflammatory diarrhea:

- يتميز بوجود دم أو قيح مع حرارة.
- ينجم غالباً عن الجراثيم الغازية أو الأوالي كزحار الأميبي أو الجراثيم المنتجة للذيفانات.
- الاستقصاءات التشخيصية تتطلب زرع البراز روتينياً.



الإسهال المزمن

هو إسهال يستمر لأكثر من 3-4 اسابيع. في هذه الحالة يجب البحث عن السبب ولا نعالج المريض عرضياً.



الفيزيولوجيا المرضية للإسهال المزمن:

1. الإسهال الحلولي Osmotic diarrhea:

❄ **الدلائل:**

- نقصان كمية البراز، مع الصيام (على الريق): نلاحظ ازدياد فجوة البراز الحلولية.

❄ **الأسباب:**

- ينجم عن زيادة المواد القليلة الامتصاص والفعالة حلولياً في لمعة الأمعاء (سوء امتصاص) مثل تناول سكر السوربيتول، لاكتولوز والأملاح غير الممتصة.
- ويظهر كإحدى التأثيرات الجانبية لبعض الأدوية كالصادات ومضادات الحموضة حيث تؤدي مثل هذه الأدوية لزيادة جذب السوائل لمعة الأمعاء أو الأدوية الملينة، وقد يظهر كعرض لمرض عدم تحمل اللاكتوز ويكون علاج هذه الإسهالات باتباع الحمية.
- عوز أنزيم دي سكاريداز: عدم تحمل اللاكتوز.
- الاسهال الكاذب: يؤدي إلى نقص المغنيزيوم (مضادات الحموضة، ملينات الأمعاء).

2. الإسهال الإفرازي Secretory diarrhea:

❄ **الدلائل:**

- كمية كبيرة (أكبر من 1ليتر في اليوم). تغيرات ضئيلة أثناء الصيام: تكون الفجوة البرازية الحلولية طبيعية.

❄ **الأسباب:**

1. **آلية هرمونية:** فيبوما (الورم المفرز لعديدات الببتيد المعوية)، سرطان، سرطان الغدة الدرقية النخاعي (كالسيتونين)، متلازمة زولينجر - إيليسون (غاسترين).
2. **إسهال كاذب** (تناول مليّنات بطريقة تعسُّفية): فينول فتالئين - الكسكارة (دواء نباتي مسهل) - سنامكي.
3. **ورم غدي زغابي.**
4. **سوء امتصاص الأملاح الصفراوية:** مجهول السبب، استئصال اللفائفي، التهاب اللفائفي (داء كرون)، بعد استئصال المرارة.
5. **الأدوية.**

❄ يؤدي لزيادة إفراز الكلور والماء سواءً أدى ذلك لتثبيط أو عدم تثبيط الامتصاص الفعّال للصوديوم ومثال على ذلك الكوليرا. لا يتوقف هذا الإسهال باتباع الحمية ويعود لأسباب هرمونية، وينجم عن الالتهاب المعوي كما في الأخماج الفيروسية أو الجرثومية.

3. اضطرابات حركية الأمعاء Abnormal intestinal motility:

❄ **الدلائل:**

- الأمراض الجهازية، جراحة سابقة في البطن.

❄ **الأسباب:**

1. **بعد الجراحة:** قطع المبهم، استئصال المعدة الجزئي، عروة عمياء مع فرط نمو بكتيري.
2. **اضطرابات جهازية:** تصلب الجلد، داء السكري، فرط نشاط الدرق.
3. **متلازمة الأمعاء المتهيجة.**

❄ وغالباً ما تترافق مع نقص أو زيادة فترة التماس بين محتويات الأمعاء وسطح المخاطية.

4. الإسهال النتحي Exudation diarrhea:

❄ حيث يتم نتح المخاط والبروتين والدم والقيح من مواقع الالتهاب الفعال بالمخاطية إلى لمعة الامعاء مثال: التهاب القولون القرحي.

5. الحالات الالتهابية Inflammatory conditions:

❄ **الدلائل:**

- حمى، تغوط مدمى، ألم بطني.

❄ **الأسباب:**

1. **التهاب القولون التقرحي.**
2. **داء كرون.**
3. **التهاب القولون المجهري.**
4. **الخباثة:** لمفوما، سرطانة غدية (مع انسداد واسهال كاذب).
5. **التهاب الأمعاء الاشعاعي.**

6. متلازمات سوء الامتصاص Malabsorption syndromes:

❄ **الدلائل:**

نقصان الوزن، القيم البطنية المخبرية :براز دهني10 <غ24/ساعة.

❄ **الأسباب:**

1. **اضطرابات مخاطية الأمعاء الدقيقة:** إسهال بطني حاد، اسهال استوائي (مداري)، داء ويبل، التهاب المعدة والأمعاء اليوزيني، قطع صغير في الأمعاء (متلازمة الأمعاء القصيرة)، داء كرون.
2. **انسداد لمفاوي:** لمفومة، سرطاوي، عدوائي (السل، MAI)، ساركوما كابوزي، ساركوئيد، تليف خلف الصفاق.
3. **داء بنكرياسي:** التهاب البنكرياس المزمن، سرطانة البنكرياس.
4. **فرط النمو البكتيري:** الاضطرابات الحركية (البوال السكري، استئصال الأسهر)، تصلب الجلد، النواسير، رتج في الأمعاء الدقيقة.

7. الأدوية Medication:

❄ المسببات الشائعة: مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية SSRIs، مثبطات الكولين استيراز، مضادات التهاب غير ستيروئيدية NASIDs، مثبطات مضخة البروتون، حاصرات مستقبل الأنجيوتنسين 2، ميتفورمين[9]، آلوبورينول.

أحياناً عند مرضى الاستئصال الصفراوي يُفقَد الدوران المعوي الكبدي وبالتالي الأملاح الصفراوية لم تعد تُمتص فيحصل إسهال مزمن.

الفحص السريري

↙ نتحرى الانعكاسات على الحالة العامة:

- **الإسهال الحاد:** نبحث عن علامات نقص التميه (لسان ناشف، جلد مهلهل، حالة عامة سيئة، غور عينين) ونقوم بتعويضه بالسوائل فوراً.
- **الإسهال المزمن:** نبحث عن أعراض سوء الامتصاص ونقص الوزن ووذمة القدمين نتيجة نقص الألبومين.

[9] الميتفورمين: دواء يستخدم لتنظيم السكر لكن حاليا يستخدم للشعرانية ومبيض متعدد الكيسات وله آثار جانبية هضمية كالاسهال.

إذاً في الإسهال المزمن نبحث عن السبب بفحص سريري كامل مع مس شرجي.

الفحوص المتممة

- **فحص البراز**: تحري وجود طفيليات أو كريات بيضاء أو عناصر مرضية.
- **تنظير هضمي علوي**: عند الشك بوجود سوء امتصاص معوي أو سوء هضم نتيجة أذيات بنكرياسية أو ركودة صفراوية.
- **تنظير كولون**: عند الشك بإصابة كولونية (لتحري وجود ورم، التهاب أو أي آفة).
- **الإيكو**: لتحري وجود إصابة بنكرياسية أو ركودة صفراوية من خلال ظهور القناة الصفراوية متسداد أو غيره.
- **صور أشعة**: لتحري الأورام.
- **فحوص الدم**: نجري فحوصات للنسب الهرمونية التي من الممكن أن تسبب سوء امتصاص.



التشخيص

- **الإسهال الحاد**: نقوم باستجواب المريض وفحصه سريرياً ونلجأ لفحص البراز والدم لتشخيص سبب الحالة.
- **إسهال مزمن**: استجواب المريض ثم فحصه سريرياً وفحص البراز وفحص دم بشكل أساسي، نجري تنظير علوي للإصابات المعوية أو سفلي للإصابات القولونية حسب ما توصلنا إليه، قد نحتاج لإجراء إيكو أو أشعة كما في حالات سرطان القولون للبحث عن انتقالاته.

الإمساك Constipation

- هو بطء مرور معوي ينجم عنه تأخر في إفراغ البراز يؤدي إلى عدد مرات تبرز قليلة (تقريباً أقل من 3 مرات في الأسبوع) أو حجم صغير لبراز قاسٍ وجاف.
- يعاني منه 15٪ من الناس حوالي ثلث المرضى في عمر الخمس سنوات.
- يكون عند النساء أشيع من الرجال.

↙ المعايير التشخيصية للإمساك المزمن:

✓ وجود عرضين أو أكثر لمدة 12 أسبوع من الأعراض التالية:

إجهاد	براز قاسي	شعور بعدم الإفراغ: إفراغ غير تام، انسداد مستقيمي شرجي	استخدام التفريغ اليدوي لتسهيل التغوط	افراغ أقل من 3 مرات في الأسبوع

عندما يأتي مريض يعاني من إمساك منذ يوم أو يومين لا داعي للإعطائه الملينات لأنها قد تكون مجرد مشاكل عرضية.

الفيزيولوجيا المرضية للإمساك

↙ ينجم الإمساك عن الآليات الثلاث التالية:

❶اضطراب تقدم. ❷اضطراب تغوط (إفراغ). ❸الاثنان معا.

1. اضطراب تقدم الكتلة البرازية في القولون:

❖ ينجم اضطراب التقدم إما عن نقص في الحركات الحوية الدافعة أو زيادة في الحركات القطعية أو وجود عائق يسد الطريق أمام الكتلة البرازية فيمنعها من التقدم (التهاب، ورم، سدادة برازية).

2. اضطراب تغوط:

❖ في الحالة الطبيعية عندما يصل البراز إلى المستقيم يتمدد المستقيم (يملك القدرة على التمدد بشكل أكبر من أقسام القولون) ويبعث إشارات إلى الدماغ مُعلماً إياه بضرورة التغوط فيعطي إشارة للمعصرات الشرجية ويحدث التغوط.

❖ أما في الحالات المرضية التي تترافق بحدوث ألم عند التغوط كوجود ورم في المستقيم أو إصابة شرجية أو أي عائق (بواسير، شقوق شرجية)، يحدث منعكس لدى الإنسان يمنعه من التغوط الذي يسبب له الألم وذلك لمرحلة معينة يتغوط فيها الإنسان نتيجة زيادة الكتلة البرازية بشكل كبير جداً.

3. ترافق الآليتين السابقتين معاً:

❖ وهي الأشيع كما في تشنج القولون.

أسباب الإمساك

أولاً: هضمية:

1. **إمساك أولي أوظيفي:** هو زوال منعكس التغوط وهو الأكثر شيوعاً، يحدث نتيجة تجاهل الإشارات الواردة من المستقيم والتي تنبه الإنسان لضرورة التغوط، ومع الزمن ينعدم المنعكس لديهم ولا يتم التبرز إلا عندما يمتلئ المستقيم بكميات هائلة من البراز.
   - تشاهد 80٪ من حالات الإمساك الأولي عند النساء (لأنهن الأكثر خجلاً).
2. أورام القولون والمستقيم (وجود عائق).
3. أمراض كولون غير ورمية كتشنج القولون، التهابات وضعف الحركة.
4. أسباب نهائية (كالبواسير – الشقوق الشرجية) والتي تسبب آلام للمريض عند التغوط وبالتالي خوف نفسي من التغوط وحدوث إمساك أولي.



5. **اضطراب تغوط** (أورام – أمراض شرج).
6. **إصابة شاملة بالقولون** تسبب نقص الحركة.

ثانياً؛ غير هضمية:

1. **إصابة عصبية:** دماغية مثل: داء باركنسون، أو نخاعية مثل: إصابة النخاع، شلل، أو التهاب جذور الأعصاب الشوكية تؤدي لاضطرابات في تعصيب القولون.
2. **إصابة غدية:** قصور درق - داء سكري (اعتلال أعصاب سكري للأمعاء) - فرط نشاط جارات الدرق التي تؤدي إلى رفع تركيز شوارد الكالسيوم في الدم وإحداث إمساك شديد نتيجة زيادة شدة الحركات القطعية للأمعاء.
3. **اضطراب شوارد:**
   a) نقص بوتاسيوم ← خزل بالأمعاء ← إمساك ونفخة.
   b) زيادة كالسيوم.
4. **أدوية:** مضادات ألم – مضادات التشنج (لأنها ترخي القولون) – أدوية نفسية – مهدئات – أدوية قلبية خافضة للضغط – مضادات الكولين – أدوية السعال (كودائين).
5. **أسباب عابرة (عرضية):**
   a) حمل (ضغط للجنين). b) نقص تميه. c) قلة النشاط الفيزيولوجي (نوم طويل).
   d) حمى ← عرق ← نقص سوائل ← إمساك بسبب محاولة القولون أن يعاوض نقص السوائل عن طريق امتصاص كمية أكبر من الماء.

الاستجواب

1. نمط وزمن البدء:

- وهو أهم ما يسأل عنه مريض الإمساك: منذ متى وأنت تعاني من الإمساك؟
- قد يكون حاداً (حديث وعابر – حديث ومستمر).
- **في الإمساك الحاد يجب أن نأخذ بعين الاعتبار السرطان والخباثات.**

2. سوابق مرضية:

- أدوية.

3. صفات البراز:

- **هل يوجد دم؟**
  - فالدم الذي يغطي البراز -أي يحدث بعد التغوط- يدل على إصابة **شرجية**، بينما الدم المخلوط مع البراز يدل على إصابة **كولونية**.
  - براز زفتي (أسود) يحدث نتيجة إصابة هضمية **علوية**.

- **يوجد ألم أثناء التغوط أم لا؟**
  - بحال وجود ألم نشتبه بالشقوق الشرجية أو البواسير.
- **يوجد زحير أم لا؟**
  - وذلك لننفي أورام المستقيم.

تذكر: الزحير Tenesmus شعور بالحاجة للتغوط رغم أن المستقيم فارغ.

- هل يوجد مخاط أو قيح مع البراز؟
  - فوجودها يدل على آفة التهابية مناعية.

4. أعراض مرافقة:



- أعراض عصبية: شلل نصفي (إصابة مركزية).
- نقص وزن مترافق مع نقص شهية (إصابة ورمية).
- أعراض غدية: كما في قصور الدرق.
- حمى.
- ألم شرجي.
- نزف هضمي سفلي مع إمساك حديث (غالبا ورم).

ملاحظات هامة:

- التهاب القولون القرحي: هو التهاب يصيب مخاطية القولون بكاملها (مناطق مستمرة ومتصلة من الالتهاب)، وتكون الإصابة معزولة (أي القولون فقط)، **يترافق دائماً بوجود دم عياني في البراز**.
- داء كرون: التهاب يصيب الأمعاء وحتى فتحة الشرج، وتكون الإصابة معينة منقطعة أي يمكن أن يود في منطقة ولا يوجد في أخرى.
- يجب ان نهتم إذا كان الإمساك حديث ومترافق مع أعراض عامة (وجود دم في البراز، نقص وزن) أكثر من إمساك القديم.

الفحص السريري

- فحص سريري كامل حسب التوجه الشخصي، لكن يوجد **أهمية خاصة للمس الشرجي** عند الإمساك **المزمن خاصة**، وذلك لتحرّي وجود شقوق شرجية ولتحديد نوع الإمساك فنميز بين:
  - **مستقيم فارغ:** اضطراب تقدم كولوني، ورم أو اضطرابات حركية أو التهابات كداء كرون.
  - **مستقيم مليء:** يعود لأسباب نهائية كاضطراب التغوط، ويلاحظ عند كبار السن خاصة، ويجب في هذه الحالة إجراء تفريغ للمستقيم.

حالة سريرية

- **الاسهال الكاذب:** مريض لديه إمساك وتتشكل لديه سدادة برازية وعند الضغط تخرج السوائل وتبقى السدادة ويتم التشخيص والعلاج على أنه إسهال وبالتالي تصبح الحالة أسوأ.
- العلاج يكون بإخراج السدادة لكن قد تسبب شق شرجي ويحدث ألم فنلجأ للجراحة تحت التخدير وإخراجها على عدة مراحل.
- **الأعراض المرافقة:** حمى بسبب مشاكل انتانية، ألم شرجي بسبب باسور أو شق شرجي.

في حال جس كتلة في المستقيم فذلك يشير إلى وجود ورم في المستقيم.

الملخص

- الاضطرابات الهضمية نوعان:
  - نقص الشهية (القهم) anorexia
  - زيادة الشهية (النهم) polyphagia
- **رائحة الفم الكريهة:** 95٪ من الحالات ناتجة عن النخور السنية والتهابات اللثة.
  - للفم رائحة بول أو سمك ← انسمام يوريميائي.
  - للفم رائحة التفاح المتعفّن ← سبات كبدي.
  - للفم رائحة الخلو ← سبات سكري.
  - يشير ترافق رائحة الفم الكريهة مع براز رصاصي إلى انسداد الأمعاء.
- **العطش:** مشعر لنقص السوائل في الجسم ويعكس درجة التجفاف الخلوي.
- **جفاف الفم:** يدل على نقص السوائل الخلوية.
  - يعد الإسهال أحد أشيع أسباب العطش وجفاف الفم.
- **عسرة البلع:** هي صعوبة البلع.
  - ولها نوعان:
    - **عسرة بلع فموية:** الشعور بصعوبة إفراغ الفم من الطعام (تنتج عن وجود أورام أو التهابات في البلعوم أو الفم).
    - **عسرة بلع مريئية:** صعوبة إمرار اللقمة عبر المريء (تنجم عن اضطرابات حركية أو أسباب ميكانيكية كسرطان المري).
    - **التشخيص في حالة عسرة البلع:** نقوم بإجراء تنظير لنفي الآفة الميكانيكية وإجراء صورة ظليلة وقياس ضغوط المري وفي حال وجود آفة ميكانيكية نقوم بأخذ خزعة.
    - **عسرة البلع الميكانيكية:** تتميز بكونها حديثة، تبدأ بشكل تدريجي، استجابتها لمحاولات البلع المتكررة فاشلة ولا تتأثر بحرارة الطعام.

- **عسرة البلع الحركية:** تتميز بكونها قديمة، تحدث بشكل متردد ومفاجئ، تتأثر بالطعام البارد، واستجابتها لمحاولات البلع المتكرر فعّالة.

- **الإقياء:** الحالات الشديدة من الإقياء تسبب انثقاب المري (تناذر بورهاف).
  - **في الفحص السريري للإقياء:** نبحث عن انعكاس الإقياء على الحالة العامة (نقص وزن- نقص تميه)، ونبحث عن السبب.
  - ينبغي تمييز حرقة الفؤاد (اللذع) عن الألم الصدري القلبي من خلال طبيعته الحارقة، انتشاره نحو الأعلى، ترافقه مع القلس الحمضي، وحدوثه عند الاستلقاء أو الانحناء للأمام.
- **القلس المعدي المريئي:** يتم تشخيص القلس المعدي المريئي من خلال:
  - تنظير هضمي علوي: للبحث عن توسعات الفؤاد أو فتق معدي حجابي انزلاقي أو اضطرابات حركية.
  - قياس حموضة أسفل المري.
  - إذا ترافق القلس المعدي المريئي مع عسرة بلع فنحن أمام حالة التهاب مري.
- **الفواق:** هو تشنجات في عضلة الحجاب الحاجز تحدث بسبب تخريش موضعي للحجاب الحاجز أو بتخريش الأعصاب المعصبة له.
- **انتفاخ وتطبل البطن:** تمدد المعدة والأمعاء بوجود الغاز.
  - أسبابه:
    - ☒ نفخة شرسوفية (تمدد المعدة بالغازات): تتحسن بالتجشؤ.
    - ☒ نفخة معممة (تمدد القولون بالغازات): تتحسن بإخراج الغازات عن طريق الشرج.
    - ☒ أسباب عضوية كالأورام والتهابات القولون المزمنة والقرحات.
- **الإسهال:** زيادة عدد مرات التغوط لأكثر من ثلاث مرات في اليوم، وله نوعان:
  - **إسهال حاد:** يستمر لأقل من أسبوعين، يتم **تشخيصه** من خلال استجواب المريض وفحصه سريرياً وإجراء فحص براز وفحص للدم.
  - **إسهال مزمن:** يستمر لأكثر من 3-4 أسابيع، يتم **تشخيصه** من خلال استجواب المريض ثم فحصه سريرياً وإجراء فحص البراز والدم، ونقوم بإجراء تنظير علوي للإصابات المعوية أو سفلي للإصابات القولونية.
- **الإمساك:**
  - **الإمساك الأولي:** هو زوال منعكس التغوط، يحدث نتيجة التجاهل المستمر للإشارات الواردة من المستقيم إلى الدماغ لتنبيه الإنسان لضرورة التغوط.
  - يترافق التهاب القولون القرحي دائما بوجود دم عياني في البراز.



مصطلحات

نقص الشهية	Anorexia	تطبّل البطن	Flatulence
زيادة الشهية	Polyphagia	انتفاخ البطن	Meteorism
جفاف الفم	Xerostomia	إسهال	Diarrhea
الإلعاب	Sialorrhea	إسهال حلولي	Osmotic diarrhea
عسرة البلع	Dysphagia	إسهال إفرازي	Secretory diarrhea
الغثيان	Nausea	إسهال نتحي	Exudation diarrhea
الإقياء	Vomiting	اضطرابات حركية الأمعاء	Abnormal intestinal motility
القَلَس	Regurgitation	إسهال حاد	Acute diarrhea
الإجترار	Rumination	إسهال مزمن	Chronic diarrhea
تناذر بورهاف	Boerhaave's syndrome	دار كرون	Crohn's disease
متلازمة مالوري وايس	Mallory weiss syndrome	متلازمات سوء الامتصاص	Malabsorption syndrome
القلس المعدي المريئي	Gastroesophageal reflux	الإمساك	Constipation
التجشؤ	Eructation	الزحير	Tenesmus

"لا تنسونا من دعائكم"

